1. 急救 CPCR 醫囑 2
2. 急救 CPCR 轉送病歷 3
3. 中央靜脈導管 CVC/central venous catheter 4
4. 升壓劑 norepinephrine/levophed 4
5. 插管 on endo/intubation 與插管鎮靜 intubation sedation 5
6. 院內死亡宣告 5
7. 形式 AAD（留一口氣回家） 6
8. 胃腸道出血 GI bleeding 6
9. Pigtail 移除評估 6
10. 質子幫浦抑制劑點滴 PPI line 7
11. 心房顫動 Atrial fibrillation 與 amiodarone 7
12. Nicardipine line 泡法 7
13. 腹水抽吸檢驗 lab data for abdominal paracentesis 7
14. 主動脈剝離急作電腦斷層 emergent CT for aortic dissection 8
15. 腹痛急做電腦斷層 emergent CT for abdominal pain 8
16. 腎功能差排有顯影劑的電腦斷層 contrast CT for decreased renal function such as CKD 8
17. Insulin line 泡法（通常 for DKA/HHS） 8
18. 高血鉀緊急處置 hyperkalemia emergent management 9
19. 鉀離子補充 potassium supplement 9
20. 點滴內補鉀 KCl in IVF 9
21. 肺部復健 pulmonary rehabilitation 10
22. 輸血 blood transfusion 10
23. 雙腔導管移除 remove double lumen 10
24. 骨髓抽吸 bone marrow aspiration 10
25. 腎素與醛固酮 renin and aldosteron 10
26. 癲癇處置 seizure attack management 11
27. 機構/護理之家/安養中心/長照中心自費檢驗檢查開立 11
28. 白蛋白補充 albumin supplement 12
29. ABC 型肝炎檢驗與「化療前」BC 肝排除 12
30. 意識障礙 consciousness change 12
31. 幽門桿菌療法 Helicobacter medication 13
32. 高齡常用評估醫囑 13
33. 神奇小醫囑匯總 13

1. 急救 CPCR 醫囑

(1) 抽血、心電圖、照 X 光

A. 血液組：CBC、DC、PT、APTT、d-dimer

B. 生化組（動脈）：blood gas analysis

C. 生化組（離子）：Na、K、Cl、Ca、Mg、P

D. 生化組（肝腎）：BUN、Cr、AST、ALT、bil. T/D、GGT、ALK-P、albumin、CRP

E. 生化組（心臟）：BNP、Troponin I、CK-MB、CPK

F. 生化組（其他）：sugar、lactate、ammonia、osmole（blood ketone、urine ketone）

G. 其他檢驗：B/C (2)、U/R、U/C、Wd/C、SP/C、SP gram stain 等等

H. EKG resting（Portable）

I. Chest A-P view (supine)（Portable，會有 portable 紙單）

(2) 插管、CVC、升壓劑、其他管路

A. On critical order（會印出病危通知單，要簽章）

B. 病人嚴重度分級：A 級

C. 「intubation order」= intubation + ventilatior

D. 「CVC order」

E. 「levophed order」（500 mL 最高 run 40，250 mL 最高 run 20，起始流速從一半開始）

F. EKG monitor

G. B.P. monitor

H. Pulse oximeter (天)

I. CPR, success (after _ minutes cardiac massage)

J. On NG tube

K. NG decompression

L. On foley catheter

(3) 藥醫開立

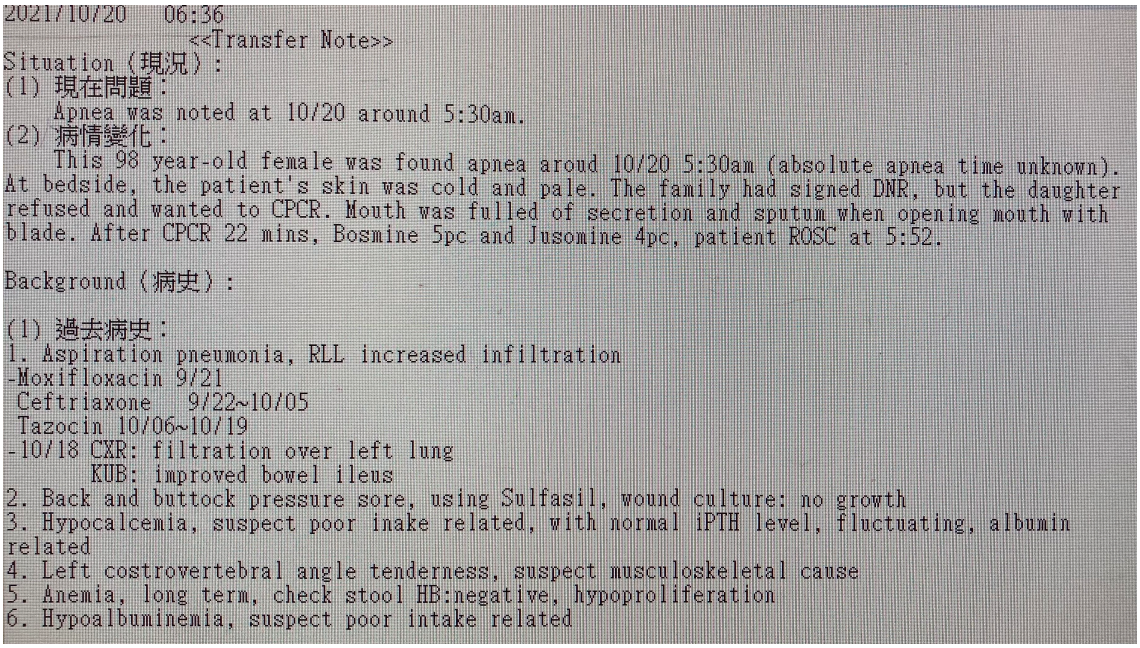
A.	Lidocaine 局部使用	1 PC	STAT	LOC	
B.	Epinephrine	_ PC	once	IV	（急救盤藥品補充）
C.	Sodium bicarbonate	_ PC	once	IVF	（急救盤藥品補充）
D.	Levophed	4 PC	IRRE	IVF	（註：用新版跳出視窗開立）
E.	Glucose 5% 500 ml/bag	500 mL	IRRE	IVF	（註：用新版跳出視窗開立）

2. 急救 CPCR 轉送病歷

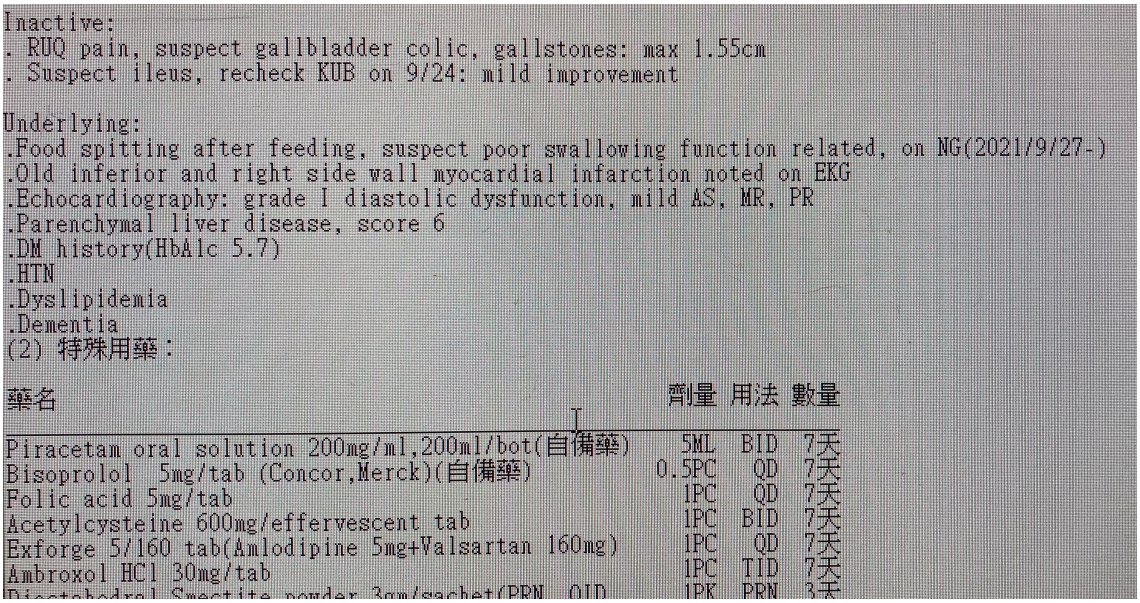
(1) found apnea around _ (absolute apnea time unknown)

(2) After CPCR _ mins, Bosmin _ PC, Jusomin _ PC, the patient ROSC at _

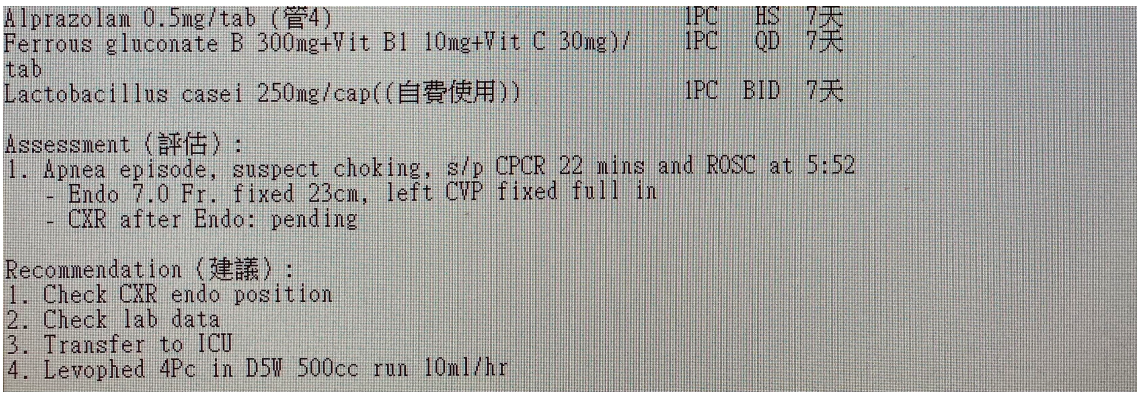
(3) 同步整流：synchronized cardioversion with 50/100/150 J；去顫：defibrillation with 200 J



```
2021/10/20   06:36
                <<Transfer Note>>
Situation (現況):
(1) 現在問題:
    Apnea was noted at 10/20 around 5:30am.
(2) 病情變化:
    This 98 year-old female was found apnea aroud 10/20 5:30am (absolute apnea time unknown).
At bedside, the patient's skin was cold and pale. The family had signed DNR, but the daughter
refused and wanted to CPCR. Mouth was fulled of secretion and sputum when opening mouth with
blade. After CPCR 22 mins, Bosmine 5pc and Jusomine 4pc, patient ROSC at 5:52.

Background (病史):

(1) 過去病史:
1. Aspiration pneumonia, RLL increased infiltration
-Moxifloxacin 9/21
 Ceftriaxone   9/22~10/05
 Tazocin 10/06~10/19
-10/18 CXR: filtration over left lung
       KUB: improved bowel ileus
2. Back and buttock pressure sore, using Sulfasil, wound culture: no growth
3. Hypocalcemia, suspect poor inake related, with normal iPTH level, fluctuating, albumin
related
4. Left costrovertebral angle tenderness, suspect musculoskeletal cause
5. Anemia, long term, check stool HB:negative, hypoproliferation
6. Hypoalbuminemia, suspect poor intake related
```



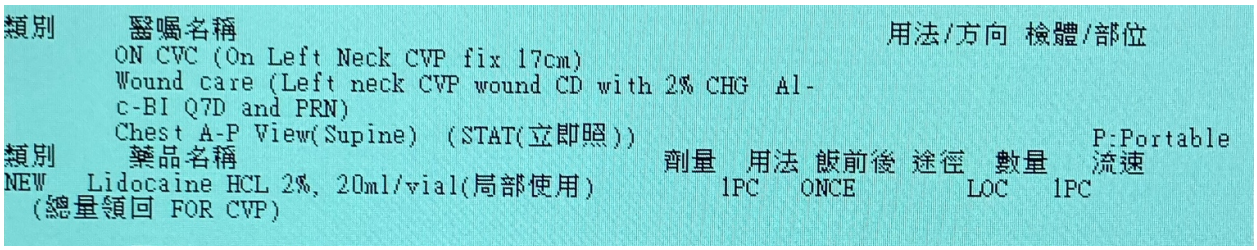
```
Inactive:
. RUQ pain, suspect gallbladder colic, gallstones: max 1.55cm
. Suspect ileus, recheck KUB on 9/24: mild improvement

Underlying:
.Food spitting after feeding, suspect poor swallowing function related, on NG(2021/9/27-)
.Old inferior and right side wall myocardial infarction noted on EKG
.Echocardiography: grade I diastolic dysfunction, mild AS, MR, PR
.Parenchymal liver disease, score 6
.DM history(HbAlc 5.7)
.HTN
.Dyslipidemia
.Dementia
(2) 特殊用藥:

藥名                                                  劑量 用法 數量
Piracetam oral solution 200mg/ml,200ml/bot(自備藥)     5ML  BID  7天
Bisoprolol  5mg/tab (Concor,Merck)(自備藥)           0.5PC   QD  7天
Folic acid 5mg/tab                                    1PC   QD  7天
Acetylcysteine 600mg/effervescent tab                 1PC  BID  7天
Exforge 5/160 tab(Amlodipine 5mg+Valsartan 160mg)     1PC   QD  7天
Ambroxol HCl 30mg/tab                                 1PC  TID  7天
Diosmectahedral Smectite powder 3gm/sachet(PRN, QID   1PK  PRN  3天
```

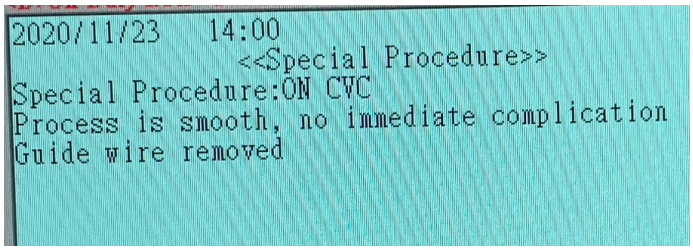


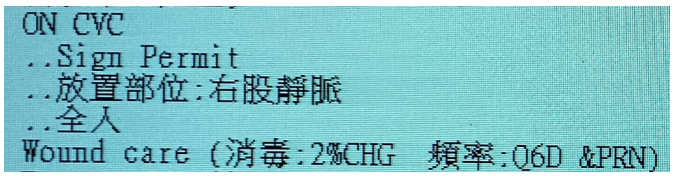
```
Alprazolam 0.5mg/tab (管4)                            1PC   HS  7天
Ferrous gluconate B 300mg+Vit B1 10mg+Vit C 30mg)/    1PC   QD  7天
tab
Lactobacillus casei 250mg/cap((自費使用))              1PC  BID  7天

Assessment (評估):
1. Apnea episode, suspect choking, s/p CPCR 22 mins and ROSC at 5:52
   - Endo 7.0 Fr. fixed 23cm, left CVP fixed full in
   - CXR after Endo: pending

Recommendation (建議):
1. Check CXR endo position
2. Check lab data
3. Transfer to ICU
4. Levophed 4Pc in D5W 500cc run 10ml/hr
```

3. 中央靜脈導管 CVC/central venous catheter

要寫 **Procedure Note**

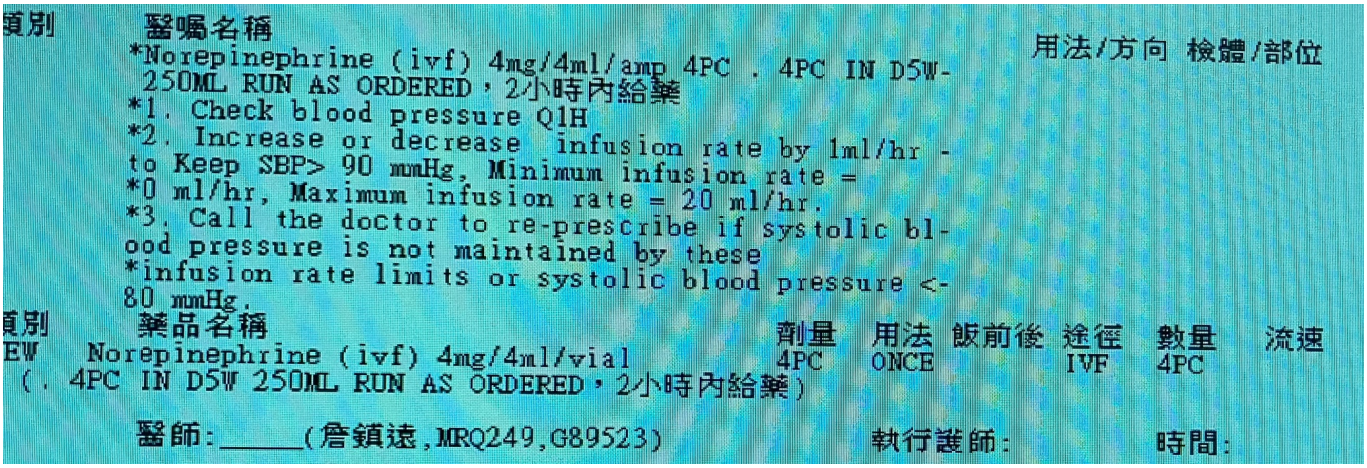


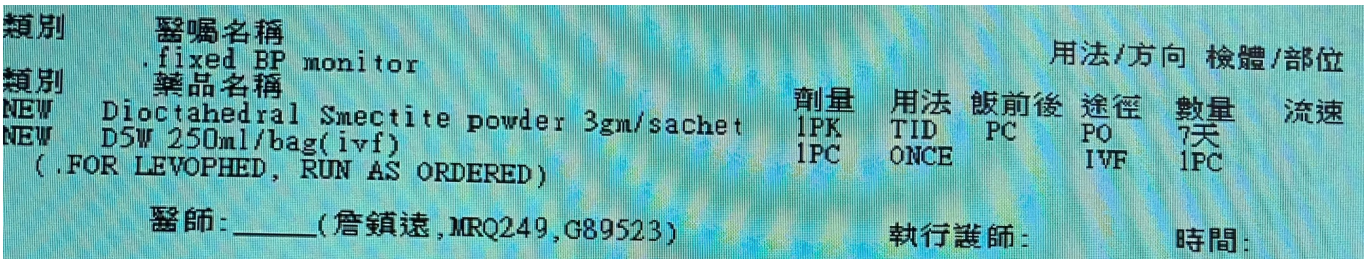




4. 升壓劑 norepinephrine/levophed

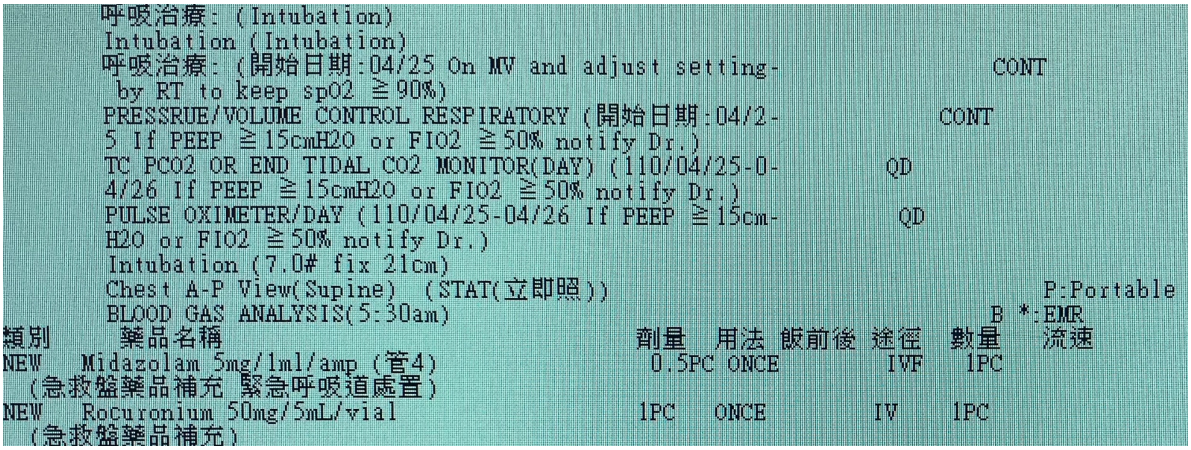
可將註明改為 MAP ≥65 mmHg

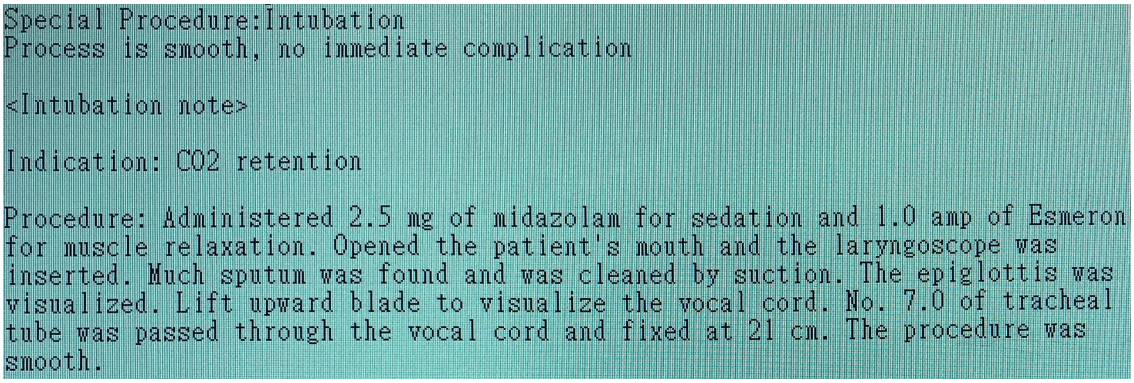


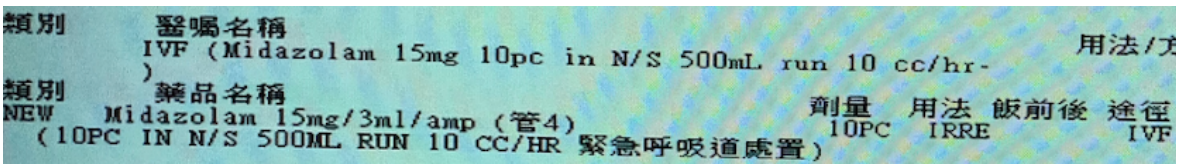


5. 插管 on endo/intubation 與插管鎮靜 intubation sedation

呼吸治療開立兩項：**intubation + ventilation**，要寫 **Duty Note（內科範本）**







6. 院內死亡宣告

(1) 乙診（若為血液腫瘤科，第一項診斷必須為癌症）

(2) 死診（女性注意懷孕，死診上的住址需與身分證一字不差）

A. 死亡原因可只寫甲病因，也可詢問 VS 或 CR （院宣通常會聯絡上級，可趁這時詢問）

B. 印出後用黑筆寫：名字、醫字號、年、月、日（這五處要蓋方章，直接蓋在字上）

(3) Order

A. Discharge order

B. Discharge today

C. 出院狀況：死亡

D. Expire time（註記：幾月幾號幾點幾分）

E. Remove NG、foley、CVC 等等

F. Wound suture over ___（PRN 開立，通常用在移除的管路留下較大的傷口）

G. 開立診斷書（註記：and 死亡證明書）

(4) 撰寫 Duty Note

7. 形式 AAD（留一口氣回家）

(1) 乙診（若為血液腫瘤科，第一項診斷必須為癌症）

(2) 撰寫出院病摘並列印（要寫到的東西：診斷、AAD）

(3) Other

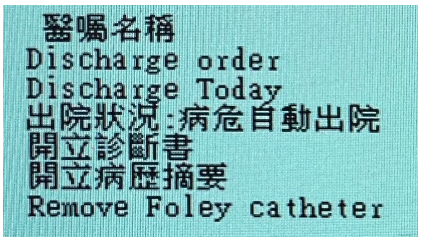
A. Discharger order

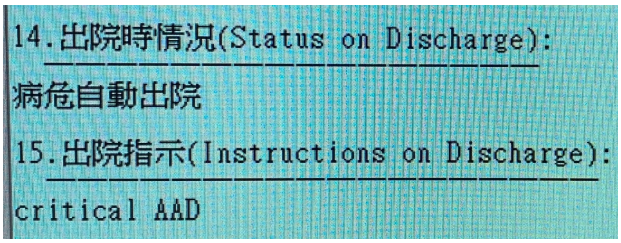
B. Discharge today

C. 出院狀況：critical AAD

D. 開立診斷書

(4) 撰寫 Duty Note





病患於110年05月10日住院，於110年05月17日辦理病危自動出院。(以下空白)

8. 胃腸道出血 GI bleeding

(1) GU、DU：先 NPO，作完胃鏡後依檢查報告寫的止血情形（很主觀）漸進 try diet

(2) EV：無 NPO 必要，但保險起見等做完胃鏡綁上橡皮筋後在開始漸進 try diet

(3) 藥物治療

A. Ceftriaxone：GU、DU、EV 都可先預防性給，5 天為上限

B. PPI：GU、DU 要給，純 EV 則無 indication

C. Glypressin：EV 才有 indication，給 3 天

(4) 值班時遇到 coffee ground 或 tarry stool

A. Check vital sign，不穩定甚至吐鮮血考慮急作胃鏡

B. 若吐 coffee ground 很多，可考慮 NG irrigation

C. NPO、DC 沒必要的口服藥、給點滴

D. UGI bleeding 三寶先上（沒做胃鏡不知道是 EV 還是 ulcer）

a. Ceftriaxone 1g 1PC QD IV

b. Glypressin 1mg 1PC Q6H IV

c. Esomeprazole 40mg 1PC Q12H IVF

※ 記得開 once

E. 抽血提早抽（重點要有 Hb、PT）

F. 備血（LPR 2U；LPP 12U；FFP 2U），視檢驗結果輸血

G. 輸完血需要再追蹤檢驗 Hb 和 PT

9. Pigtail 移除評估

(1) 通常放到完全沒量才移除

(2) 可考慮連續三天<100 mL 移除，三天後追蹤 CXR

10. 質子幫浦抑制劑點滴 PPI line

(1) Loading：esomeprazole 1amp/40mg，2PC once

(2) Maintenance（8mg/hr）：esomeprazole 1amp in NS 100mL run 20mL/hr（領 5 支回來）

11. 心房顫動 Atrial fibrillation 與 amiodarone

(1) Loading

A. 文字醫囑：Amiodarone loading 150mg in D5W 100mL IVF for 10 mins（外科可能 30 mins）

B. 藥囑：Amidarone HCl 150mg/3ml/amp，1PC once IVF（2 小時內給藥）

(2) Maintenance（loading 後還是繼續跳 AF）

A. 文字醫囑：Amiodarone line: 6amp in D5W 500mL run 34mL/hr for 6 hrs then 17mL/hr for 18 hrs

B. 藥囑：Amiodarone HCl 150mg/3ml/amp，6PC STAT IVF（急救藥盤補充）

12. Nicardipine line 泡法

(1) 醫囑：

A. Nicardipine line: nicardipine 5 PC in N/S 250 mL run 10mL/hr

B. Keep SBP 150-160 mmHg

C. Nicardipine line: SBP >160 mmHg 上調 2mL/hr

D. Nicardipine line: SBP 130-160 mmHg 下調 2mL/hr

E. Hold nicardipine line if SBP <130 mmHg

F. Check SBP Q1H or Q2H

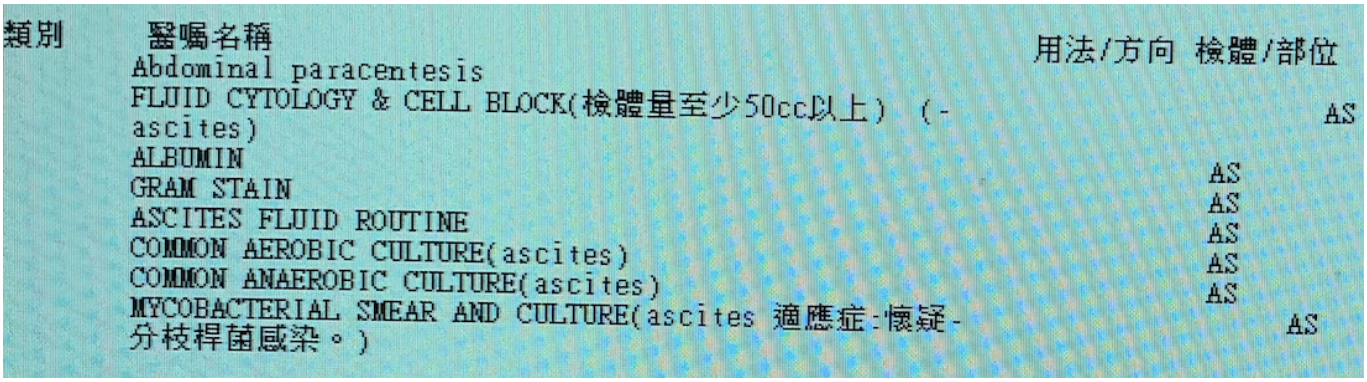
(2) 藥囑：

A. Nicardipine HCl 10mg/10ml/PC　5PC　IRRE　IVF（in N/S 250 mL run 10mL/hr）

B. NaCl 0.9%, 250mL/bag　1PC　IRRE　IVF（for nicardipine line run as order）

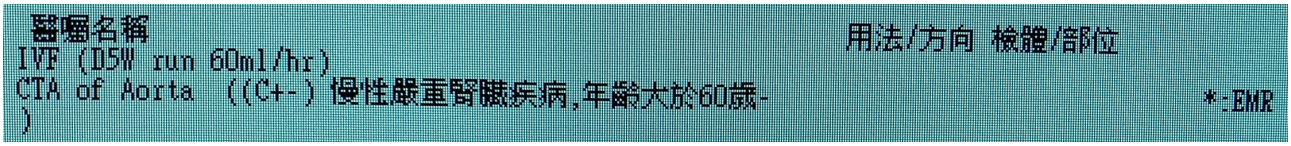
13. 腹水抽吸檢驗 lab data for abdominal paracentesis

可加驗 total protein AS，並文字敘述引流量與顏色



14. 主動脈剝離急作電腦斷層 emergent CT for aortic dissection

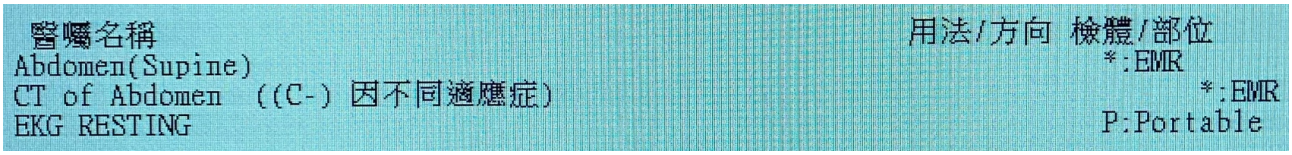
需注意患者的**腎功能**，須解釋清楚檢查後腎臟會爛掉**可能需要洗腎**



醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
IVF (D5W run 60ml/hr)		
CTA of Aorta ((C+-) 慢性嚴重腎臟疾病,年齡大於60歲-)		*:EMR

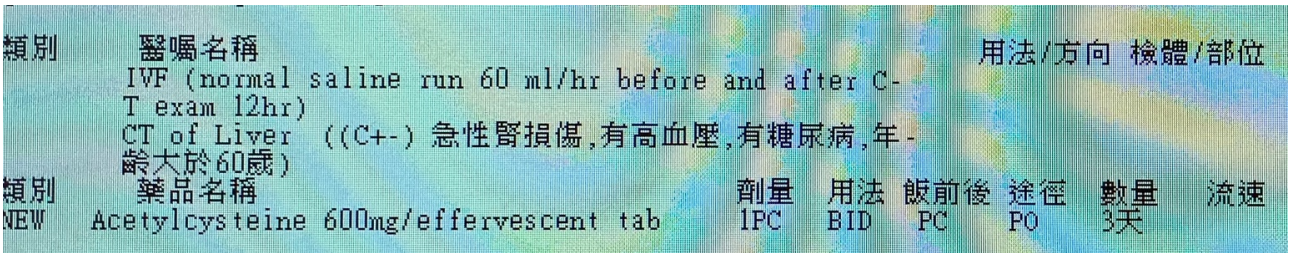
15. 腹痛急做電腦斷層 emergent CT for abdominal pain

若需顯影劑，需注意患者的**腎功能**，須解釋清楚檢查後腎臟會爛掉**可能需要洗腎**



醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
Abdomen(Supine)		*:EMR
CT of Abdomen ((C-) 因不同適應症)		*:EMR
EKG RESTING		P:Portable

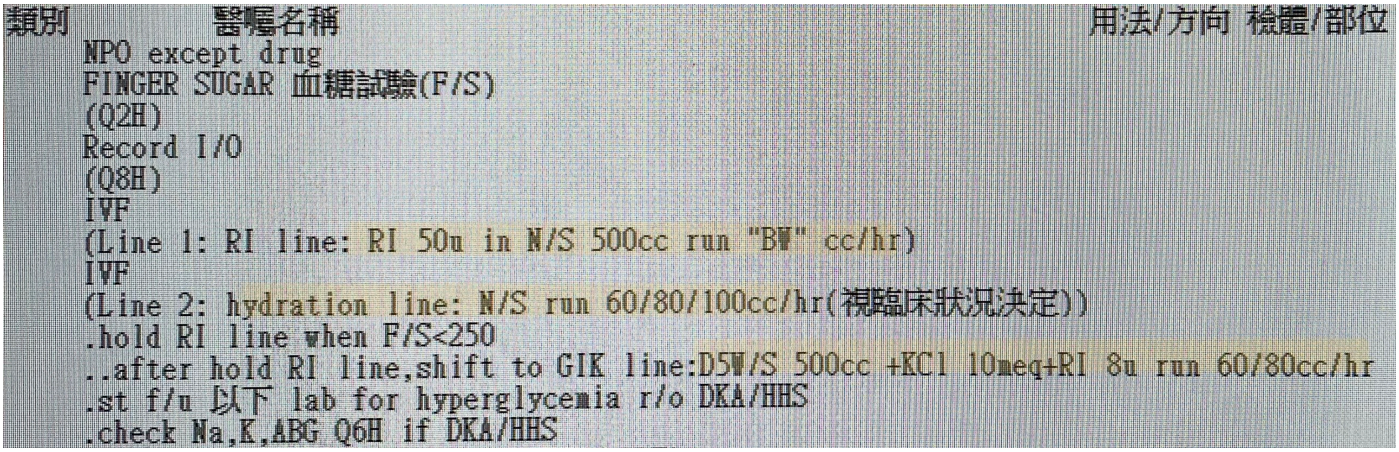
16. 腎功能差排有顯影劑的電腦斷層 contrast CT for decreased renal function such as CKD



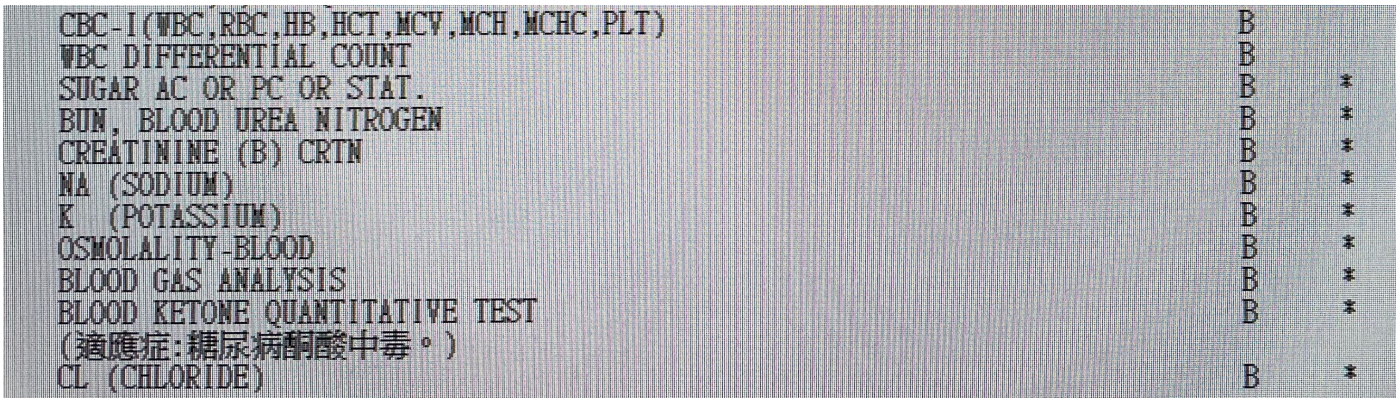
類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	IVF (normal saline run 60 ml/hr before and after CT exam 12hr)		
	CT of Liver ((C+-) 急性腎損傷,有高血壓,有糖尿病,年齡大於60歲)		

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	流速
NEW	Acetylcysteine 600mg/effervescent tab	1PC	BID	PC	PO	3天	

17. Insulin line 泡法（通常 for DKA/HHS）



類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	NPO except drug		
	FINGER SUGAR 血糖試驗(F/S)		
	(Q2H)		
	Record I/O		
	(Q8H)		
	IVF		
	(Line 1: RI line: RI 50u in N/S 500cc run "BW" cc/hr)		
	IVF		
	(Line 2: hydration line: N/S run 60/80/100cc/hr(視臨床狀況決定))		
	.hold RI line when F/S<250		
	..after hold RI line,shift to GIK line:D5W/S 500cc +KCl 10meq+RI 8u run 60/80cc/hr		
	.st f/u 以下 lab for hyperglycemia r/o DKA/HHS		
	.check Na,K,ABG Q6H if DKA/HHS		



	CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT)	B	
	WBC DIFFERENTIAL COUNT	B	
	SUGAR AC OR PC OR STAT.	B	*
	BUN, BLOOD UREA NITROGEN	B	*
	CREATININE (B) CRTN	B	*
	NA (SODIUM)	B	*
	K (POTASSIUM)	B	*
	OSMOLALITY-BLOOD	B	*
	BLOOD GAS ANALYSIS	B	*
	BLOOD KETONE QUANTITATIVE TEST	B	*
	(適應症:糖尿病酮酸中毒。)		
	CL (CHLORIDE)	B	*

18. 高血鉀緊急處置 hyperkalemia emergent management

(1) 鈣鹽 (穩定細胞膜電位)：**氯化鈣 Ca chloride (10%) IV 5~10 mL** 或 **葡萄糖醛酸鈣 Ca gluconate (10%) IV 15~30 mL**。

(2) 碳酸氫鈉 (重新分佈，讓鉀離子回到細胞內)：**NaHCO3 50 mEq IV**，可以15分鐘重複注射一次。

(3) 胰島素＋葡萄糖 (重新分佈)：**常規胰島素 Regular Insulin 10 U 加上 D50W 50 mL**。

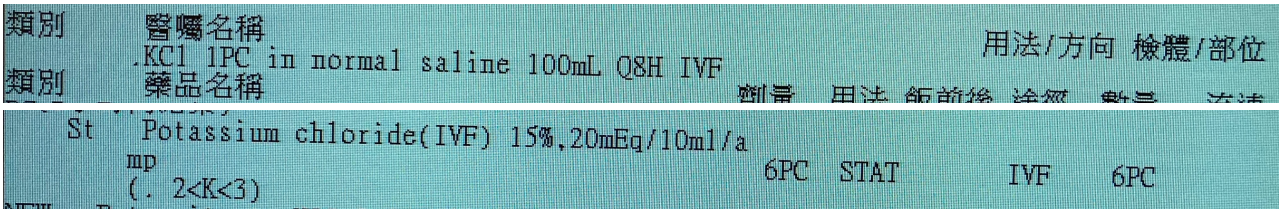
(4) 吸入型支氣管擴張劑 (重新分佈)：例如 Albuterol 或稱 **Salbutamol (Ventolin)** 汽化噴霧劑 10~20 mg，可以重複給予。

(5) 利尿劑 (增加排除)：例如 **Furosemide 40~80 mg IV**，但要等到有尿液排出才開始降低血鉀。

(6) 陽離子交換樹脂 (增加排除，也減少吸收)：例如 **Keyexalate** 或 **Kalimate**，但要等到排便才開始降低血鉀，很慢喔！

(7) 血液透析或腹膜透析：雖然有效降低鉀離子濃度，但要植入導管、架設透析機、有專人協助，很很慢喔！

19. 鉀離子補充 potassium supplement



(1) 抽血檢驗 K 下降 1 mEq/L，代表身體大約少了 200 mEq 的 K

(2) 一支 KCl 的含 K 量與體積：20 mEq/10mL/amp

(3) 周邊 line 濃度 20 ~ 40 mEq/L；中央 CVC 濃度 40 ~ 80 mEq/L

(4) 周邊 line 流速 10 mEq/h；中央 CVC 流速 20 mEq/h

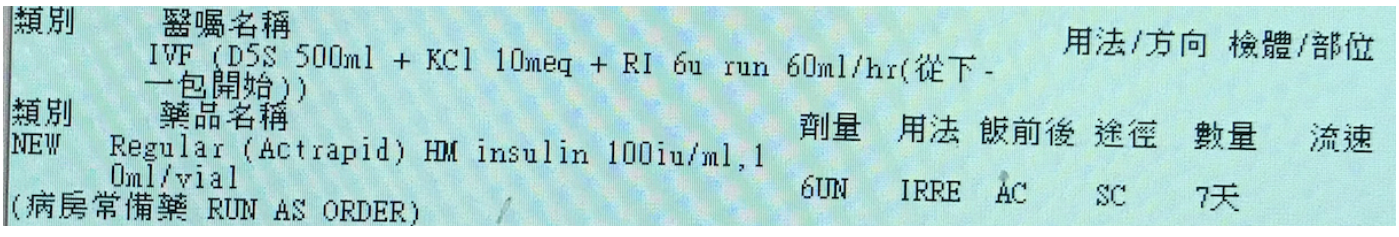
(5) 泡製時，normal saline 較 D5W 或 D5S 為佳

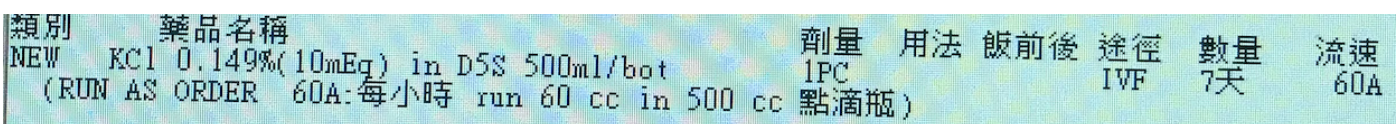
(6) 範例泡法：

A. 半支泡於 N/S 500 mL（20 mEq/L），除非點滴流速為 250 mL/h，不然不會超過 10 mEq/h

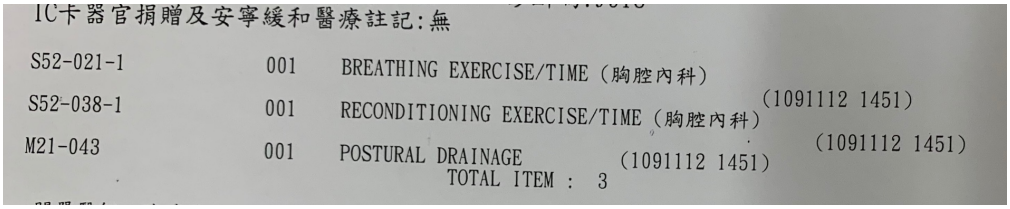
B. 周邊 line 極限就是 1 支泡 1 包（40 mEq/L），一包共 20 mEq，滴大於 2 小時即可

20. 點滴內補鉀 KCl in IVF





21. 肺部復健 pulmonary rehabilitation

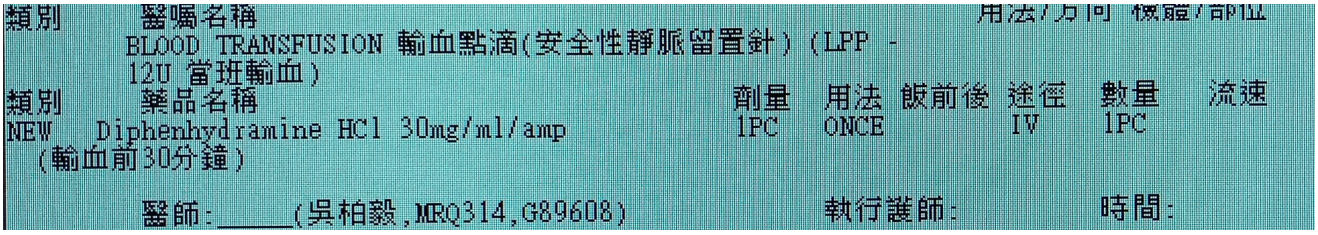


IC卡器官捐贈及安寧緩和醫療註記:無

S52-021-1	001	BREATHING EXERCISE/TIME (胸腔內科)	
S52-038-1	001	RECONDITIONING EXERCISE/TIME (胸腔內科)	(1091112 1451)
M21-043	001	POSTURAL DRAINAGE (1091112 1451)	(1091112 1451)

TOTAL ITEM : 3

22. 輸血 blood transfusion

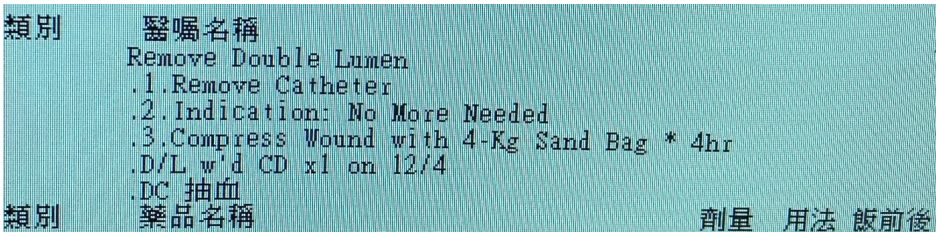


類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	BLOOD TRANSFUSION 輸血點滴(安全性靜脈留置針)(LPP - 12U 當班輸血)		

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	流速
NEW	Diphenhydramine HCl 30mg/ml/amp (輸血前30分鐘)	1PC	ONCE		IV	1PC	

醫師:_____(吳柏毅,MRQ314,G89608) 執行護師: 時間:

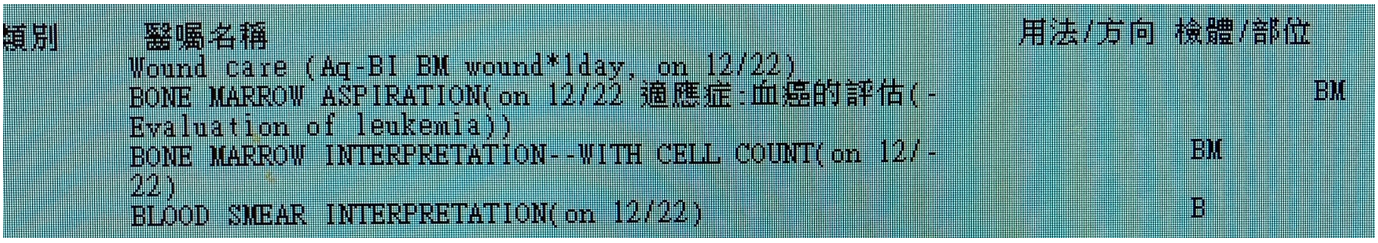
23. 雙腔導管移除 remove double lumen



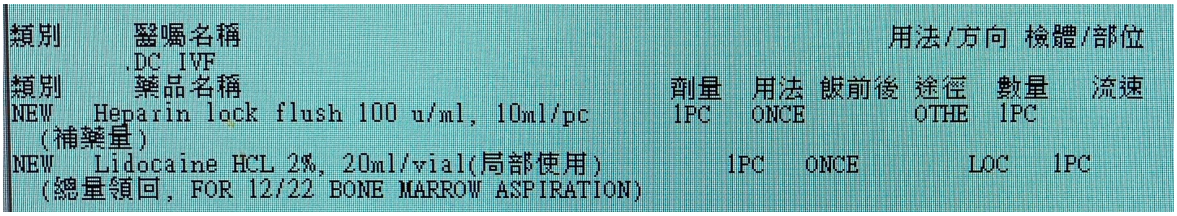
類別	醫囑名稱
	Remove Double Lumen .1.Remove Catheter .2.Indication: No More Needed .3.Compress Wound with 4-Kg Sand Bag * 4hr .D/L w'd CD x1 on 12/4 .DC 抽血

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後

24. 骨髓抽吸 bone marrow aspiration



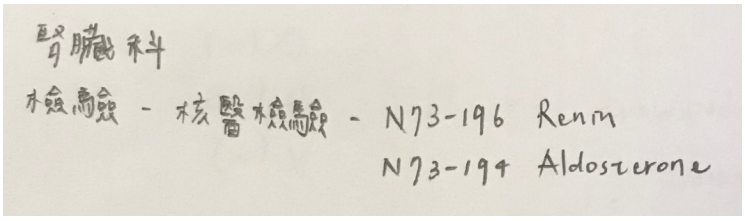
類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	Wound care (Aq-BI BM wound*1day, on 12/22)		
	BONE MARROW ASPIRATION(on 12/22 適應症:血癌的評估(-Evaluation of leukemia))		BM
	BONE MARROW INTERPRETATION--WITH CELL COUNT(on 12/-22)		BM
	BLOOD SMEAR INTERPRETATION(on 12/22)		B



類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	.DC IVF		

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	流速
NEW	Heparin lock flush 100 u/ml, 10ml/pc (補藥量)	1PC	ONCE		OTHE	1PC	
NEW	Lidocaine HCL 2%, 20ml/vial(局部使用) (總量領回, FOR 12/22 BONE MARROW ASPIRATION)	1PC	ONCE		LOC	1PC	

25. 腎素與醛固酮 renin and aldosteron

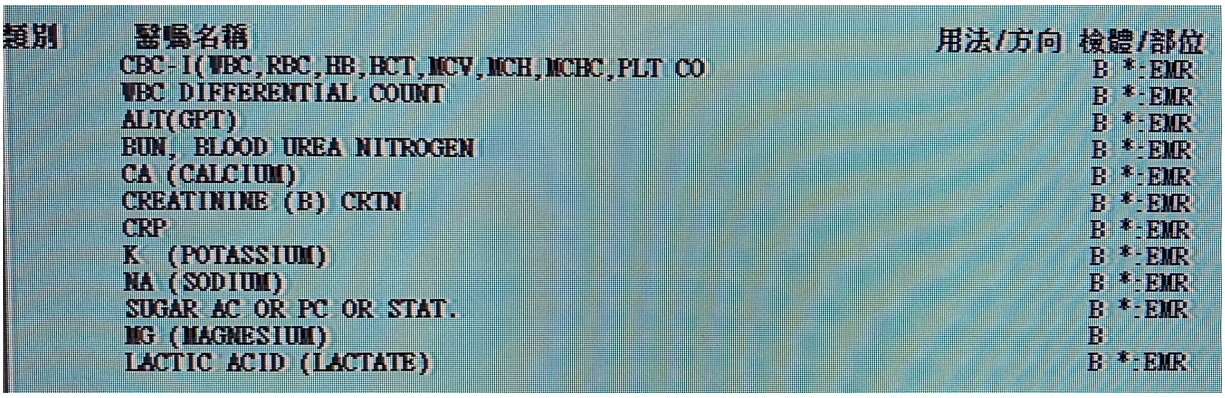


腎臟科

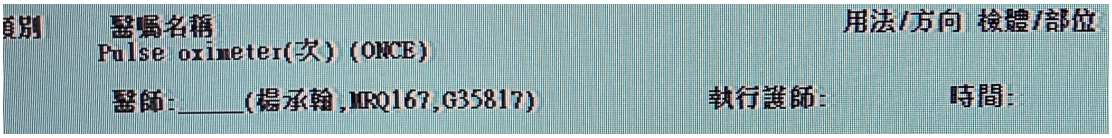
檢驗費 - 核醫檢驗 - N73-196 Renin

N73-194 Aldosterone

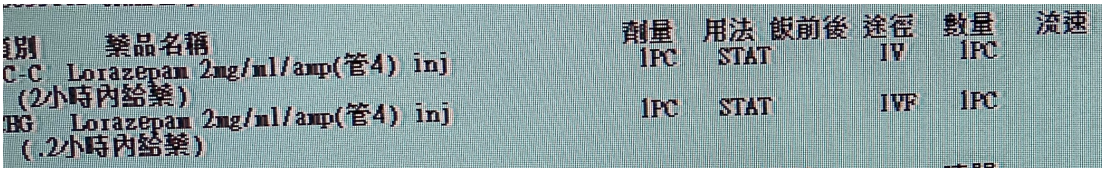
26. 癲癇處置 seizure attack management



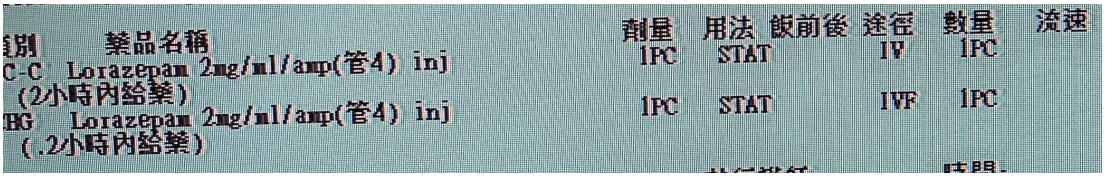
類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT CO		B *:EMR
	WBC DIFFERENTIAL COUNT		B *:EMR
	ALT(GPT)		B *:EMR
	BUN, BLOOD UREA NITROGEN		B *:EMR
	CA (CALCIUM)		B *:EMR
	CREATININE (B) CRTN		B *:EMR
	CRP		B *:EMR
	K (POTASSIUM)		B *:EMR
	NA (SODIUM)		B *:EMR
	SUGAR AC OR PC OR STAT.		B *:EMR
	MG (MAGNESIUM)		B
	LACTIC ACID (LACTATE)		B *:EMR



類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	Pulse oximeter(次) (ONCE)		
	醫師:_____(楊承翰,MRQ167,G35817) 執行護師: 時間:		



類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	流速
C-C	Lorazepam 2mg/ml/amp(管4) inj (2小時內給藥)	1PC	STAT		IV	1PC	
HG	Lorazepam 2mg/ml/amp(管4) inj (.2小時內給藥)	1PC	STAT		IVF	1PC	



類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	流速
C-C	Lorazepam 2mg/ml/amp(管4) inj (2小時內給藥)	1PC	STAT		IV	1PC	
HG	Lorazepam 2mg/ml/amp(管4) inj (.2小時內給藥)	1PC	STAT		IVF	1PC	

27. 機構/護理之家/安養中心/長照中心自費檢驗檢查開立

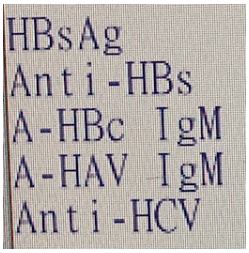
類別	檢驗項目	檢驗代號	預估單價
放射線	Chest X-ray	X75-011	$250
痰液	AFB smear*3套 CXR有浸潤時才執行	L72-623	$180
生化	BUN	L72-307	$50
生化	CR	L72-333	$60
生化	Na	L72-355	$40
生化	K	L72-356	$40
生化	GOT/AST	L72-360	$50
生化	GPT/ALT	L72-361	$50
血液	CBC	L72-001	$200
血液	Albumin	L72-303	$50
糞便	Ameba	L72-741	$60
糞便	Ova concentration	L72-735	$350
糞便	Salmonella and shi	L72-601	$300
尿液	urine routine	L72-701	$75
HIV(72-957) VDRL(72-101)		總金額	$1,755

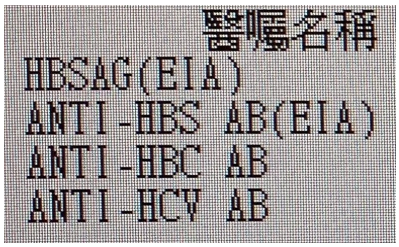
28. 白蛋白補充 albumin supplement

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量	天
DC-D	Albumin(IVF) 25%,50ml/bag (血液製劑)		1PC	BID		IVF	3天
	(TOTAL 6PC, 1/5PM至1/8AM, INDICATION: ALBUMIN <2.5; CIRRHOSIS)						

用量	日期 年 月 日	用量(瓶)	檢驗結果 A/G(gm/dl)	檢查日期	審查結果
	2021 / 1 / 21	6	2.10	2021 / 1 / 21	
	/ /			/ /	
	/ /			/ /	

29. ABC 型肝炎檢驗與「化療前」BC 肝排除





30. 意識障礙 consciousness change

類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	Lab & Exam: (stat)		
	CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT CO		B *:EMR
	WBC DIFFERENTIAL COUNT		B *:EMR
	CRP		B *:EMR
	LACTIC ACID (LACTATE)		B *:EMR
	AMMONIA		B *:EMR
	NA (SODIUM)		B *:EMR
	K (POTASSIUM)		B *:EMR
	CA (CALCIUM)		B *:EMR
	P (PHOSPHORUS)		B *:EMR
	BLOOD GAS ANALYSIS		B *:EMR
	TROPONIN I		B *:EMR
	CK-MB		B *:EMR
	ALT(GPT)		B *:EMR
	BUN, BLOOD UREA NITROGEN		B *:EMR
	CREATININE (B) CRTN		B *:EMR
	BILIRUBIN TOTAL(EMR)		B *:EMR
	BILIRUBIN DIRECT(EMR)		B *:EMR
	AST(GOT)		B *:EMR

類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	Chest A-P View(Supine) (醫療處置後，再電話通知照像-P:Portable)		

類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	FINGER SUGAR(血糖試驗) (once)		

類別	醫囑名稱	用法/方向	檢體/部位
	CT of Brain ((C-) 因病情變化)		*:EMR

31. 幽門桿菌療法 Helicobacter medication

類別	藥品名稱	劑量	用法	飯前後	途徑	數量
NEWD	Clarithromycin 500mg/fc tab	1PC	BID	PC	PO	11天
NEWD	Amoxycillin 500mg/cap	2PC	BID	PC	PO	11天
NEWD	Esomeprazole mups 40mg/tab(Nexium,AstraZeneca)	1PC	QD	AC	PO	11天

32. 高齡常用評估醫囑

本院編號	健保編號	健保點數	項目名稱
M28-021-8	45052C	687	Intelligence Assessment (包括CDR)
M28-023-8	45055C	859	Personality Assessment (註:限由精神科醫師或臨床心理師施行)
M28-037-8	45046C	344	Psychophysiological Function Examination (包括MMSE)
M28-057-8	45058C	1375	Multiphasic psychological Test (包括CASI)

33. 神奇小醫囑匯總

(1) 痠痛貼布：Flurbi patch、flurbiprofen

(2) 瘀青藥膏：Heparinoid

(3) 痔瘡藥膏：High Xylmol

(4) 電腦斷層顯影劑，保護腎臟藥：acetylcysteine 600mg

(5) 薄荷油揉肚子：處置 menthol paking

(6) 口腔破藥膏：triamcinolone

(7) 香港腳藥膏：ciclopirox olamine 1% cream